WINNICOTT

Gioco e realtà

ARMANDO EDITORE

Capitolo primo

Oggetti transizionali e fenomeni transizionali (1971)

In questo capitolo presenterò l'ipotesi originale che ho formulato nel 1951, e la farò seguire da due esempi clinici.

I. Ipotesi originale[1]

È ben noto che i bambini non appena vengono al mondo tendono a usare pugno, dita, pollice per stimolare la zona erogena orale: in tal modo soddisfano gli istinti relativi a quella zona, e si trovano in contatto con essi in modo tranquillo. È anche risaputo che, pochi mesi dopo, i bambini di entrambi i sessi si divertono a giocare con i bambolotti e che quasi tutte le madri danno al figlio qualche oggetto speciale aspettandosi che diventi, come di fatto succede, molto dipendente da esso.

Vi è un rapporto tra questi due ordini di fenomeni, che sono separati da un intervallo di tempo, ed uno studio dello sviluppo dal primo fenomeno a quello successivo può essere utile e può fare uso di un materiale clinico importante che è stato, in qualche modo, trascurato.

[1] Pubblicato sull'*International Journal of Psycho-Analysis*, vol. 34, parte 2 (1953); e in D. W. Winnicott, *Dalla pediatria alla psicoanalisi* (1958a).

Il primo possesso

Coloro che si trovano ad essere in stretto contatto con gli interessi e i problemi delle madri si saranno già resi conto della varietà dei modi in cui i bambini usano il loro primo possesso 'non-me'. Queste modalità, essendo manifeste, possono essere sottoposte a osservazione diretta.

C'è un'ampia variabilità nella sequenza degli eventi che inizia con le attività del neonato intorno al pugno-in-bocca e che può portare, alla fine, all'attaccamento a un orsacchiotto, a una bambola, a un giocattolo soffice o a uno duro.

È chiaro che qui c'è qualcosa di importante, a prescindere da eccitazione e soddisfazione orale, sebbene questa possa essere la base di tutto ciò che segue. Si possono studiare molti altri aspetti che includono:

1. La natura dell'oggetto.
2. La capacità del bambino di riconoscere l'oggetto come non-me.
3. La sede dell'oggetto – fuori, dentro, sul limitare.
4. La capacità del bambino di creare, pensare, inventare, dare origine, produrre un oggetto.
5. L'inizio di un rapporto oggettuale di carattere affettivo.

Ho introdotto i termini 'oggetti transizionali' e 'fenomeni transizionali' per definire l'area intermedia di esperienza tra il pollice e l'orsacchiotto, tra l'erotismo orale e un vero rapporto oggettuale, tra l'attività creativa primaria e la proiezione di ciò che è stato già introiettato, tra l'inconsapevolezza primaria di un debito e il rendersi conto del debito ('Dì: 'Grazie!').

Con questa definizione la lallazione del bambino e il modo in cui il bambino più grande ripete il suo

repertorio di canzoncine o di filastrocche, mentre si prepara per andare a letto, rientrano nell'area intermedia come fenomeni transizionali insieme all'uso che il bambino fa di oggetti che non sono parte del suo corpo ma che non sono ancora pienamente riconosciuti come appartenenti alla realtà esterna.

Inadeguatezza della consueta definizione di natura umana

È generalmente riconosciuto che la definizione della natura umana in termini di rapporti interpersonali non è abbastanza soddisfacente, anche se si include l'elaborazione immaginativa della funzione e l'intera fantasia conscia ed inconscia, compreso l'inconscio rimosso. Per descrivere le persone c'è un altro modo che emerge dalle ricerche degli ultimi vent'anni. Di ogni individuo che ha raggiunto lo stadio di essere una unità, con una membrana che delimita, con un esterno e un interno, si può dire che vi sia una *realtà interna* per quell'individuo, un mondo interno che può essere ricco o povero, e che può essere in pace o in guerra. Questo ci aiuta, ma è sufficiente?

Ciò che vorrei affermare è che se c'è bisogno di questa doppia definizione, c'è anche bisogno di una tripla definizione; la terza parte della vita di un essere umano, una parte che noi non possiamo ignorare, è una area intermedia di *esperienza* a cui contribuiscono realtà interna e vita esterna. È un'area che non viene messa in discussione, poiché nessuno la reclama a parte il fatto che esisterà come area-di riposo per l'individuo impegnato nel perpetuo compito umano di mantenere separate, e tuttavia correlate, realtà interna e realtà esterna.

Normalmente si fa riferimento all''esame-di-realtà' e si fa una distinzione precisa fra appercezione e percezione. Io qui sto spezzando una lancia in favore di uno stato intermedio tra la incapacità e la crescente capacità del bambino di riconoscere e accettare la realtà. Sto, quindi, studiando la sostanza dell'*illusione*, quella che è concessa al bambino e che, nella vita adulta, è parte integrante dell'arte e della religione e che, però, diventa il marchio della follia se un adulto richiede in modo eccessivo la credulità degli altri, costringendoli a condividere un'illusione che non è loro.

Possiamo condividere il rispetto per *l'esperienza illusoria* e, se si vuole, ci si può riunire e formare un gruppo sulla base della somiglianza delle esperienze illusorie. Questa è l'origine naturale del fare gruppo tra esseri umani.

Spero che si capisca che non mi sto riferendo esattamente all'orsacchiotto del bambino piccolo, o al primo uso, da parte del neonato, del pugno (o del pollice o delle dita). Non sto specificatamente studiando il primo oggetto dei rapporti oggettuali. Mi interessa il primo oggetto posseduto e l'area intermedia compresa tra ciò che è soggettivo e ciò che è oggettivamente percepito.

Sviluppo di un modello personale

Vi sono molti riferimenti nella letteratura psicoanalitica circa il passaggio da 'mano in bocca' a 'mano sui genitali', ma forse ce ne sono meno rispetto al passo successivo verso il manipolare oggetti come veri oggetti 'non-me'. Prima o poi, nello sviluppo di un bambino, compare

la tendenza a far entrare oggetti altro-da-me nello schema personale. In un certo senso, questi oggetti stanno per il seno ma non è questo il punto in discussione.

Nel caso di alcuni bambini, il pollice viene messo in bocca mentre le altre dita accarezzano la faccia con movimenti di pronazione e di supinazione dell'avambraccio. La bocca è, allora, attiva in rapporto al pollice ma non in rapporto alle dita. Le dita che accarezzano il labbro superiore, o qualche altra parte, possono essere o diventare più importanti del pollice che occupa la bocca. In più, questa attività di accarezzare può essere presente da sola, senza l'unione più diretta pollice-bocca. Di solito, a complicare l'esperienza auto-erotica di succhiarsi il pollice, accade una delle cose seguenti:

1. con l'altra mano il bambino porta in bocca, insieme alle dita, un oggetto esterno, per esempio una parte di lenzuolo o di coperta;
2. in un modo o in un altro, il pezzo di stoffa è stretto e succhiato o non proprio succhiato; normalmente, gli oggetti usati comprendono tovaglioli e (più tardi) fazzoletti, e ciò dipende da cosa è disponibile sempre e facilmente;
3. il bambino incomincia dai primi mesi a tirare i pelucchi della lana e a raccoglierli e usarli come parte dell'attività di accarezzare; meno comunemente la lana viene ingoiata, anche causando problemi;
4. compaiono movimenti della bocca accompagnati da suoni come 'ma-ma', lallazioni, rumori anali, le prime note musicali e così via.

Si potrebbe supporre che il pensare o il fantasticare si leghino a queste esperienze funzionali.

Sono tutte queste cose che chiamo *fenomeni transizionali*. Inoltre, all'infuori di tutto ciò (se si osserva un qualsiasi bambino) può emergere qualcosa o qualche fenomeno – forse un batuffolo di lana o l'angolo della coperta o del piumino, o una parola o una melodia o un rituale – il cui uso diventa di vitale importanza per il bambino al momento di andare a dormire e rappresenta una difesa contro l'angoscia, soprattutto l'angoscia di tipo depressivo. Forse il bambino ha trovato e usato qualche oggetto soffice o di qualche altro tipo e questo diventa, allora, ciò che chiamo *oggetto transizionale*. Questo oggetto diventa sempre più importante. I genitori si accorgono della sua importanza e se lo portano dietro quando viaggiano. La madre lo lascia diventare sporco e anche puzzolente sapendo che, lavandolo, introdurrebbe una rottura nella continuità dell'esperienza del bambino, una rottura che può distruggere il significato e l'importanza di quell'oggetto per il bambino.

Suggerisco che il modello di fenomeno transizionale cominci a comparire tra i quattro/sei mesi fino agli otto/dodici mesi. Di proposito lascio spazio per ampie variazioni.

I modelli stabiliti nella primissima infanzia possono persistere nell'infanzia, così che l'oggetto soffice originario continua a essere assolutamente necessario al momento di andare a letto o in momenti di solitudine o quando arriva un po' di depressione. In condizioni di salute, tuttavia, c'è un graduale ampliamento della gamma di interessi, e alla fine questa gamma più estesa viene mantenuta anche quando si avvicina un'angoscia depressiva. Il bisogno di un oggetto specifico o di un rituale iniziato molto presto può comparire di nuovo quando il bambino è più grande e vi sia la minaccia di una deprivazione.

Il primo possesso viene usato in connessione con speciali tecniche che derivano dalla primissima infanzia, che

possono includere attività auto-erotiche più dirette o esistere al di fuori di esse. Gradualmente, nella vita di un bambino, vengono acquisiti orsacchiotti, bambole e oggetti duri. I maschi, in qualche misura, tendono a passare all'uso di oggetti duri mentre le femmine tendono a procedere senza cambi di direzione verso l'acquisizione di una famiglia. È importante notare, tuttavia, che *non c'è una grande differenza tra maschi e femmine nell'uso del possesso 'non-me' originario*, che chiamo oggetto transizionale.

Non appena il bambino incomincia a usare suoni organizzati ('mam', 'ta', 'da') può comparire una 'parola' che indica l'oggetto transizionale. Il nome dato dal bambino a questi primissimi oggetti è spesso significativo e, normalmente, include in parte la parola che usano gli adulti. Per esempio 'baa' può essere il nome, e la 'b' può essere derivata dall'uso dell'adulto della parola 'bambino' o 'bambolotto'.

Devo precisare che talvolta non c'è un oggetto transizionale a eccezione della madre stessa. Oppure un bambino può essere così disturbato nel suo sviluppo emozionale che non può godere di uno stato di transizione, oppure la sequenza degli oggetti usati viene interrotta. Tale sequenza, tuttavia, può essere conservata in modo nascosto.

Riassunto delle caratteristiche specifiche del rapporto

1. Il bambino ha diritto all'oggetto, e noi siamo d'accordo su questo assunto. Tuttavia, sin dall'inizio, c'è una sorta di rinuncia all'onnipotenza.
2. L'oggetto viene coccolato affettuosamente e, contemporaneamente, viene amato in modo eccitato e viene mutilato.

3. Non deve cambiare mai, a meno che non venga cambiato dal bambino.
4. Deve sopravvivere all'amore istintuale e anche all'odio e, nel caso ci fosse, all'aggressività pura.
5. Al bambino, di fatto, deve sembrare che l'oggetto dia calore, o che si muova, o che abbia consistenza, o che faccia qualcosa che sembri mostrare che ha vitalità o realtà di per sé.
6. Secondo noi proviene dall'esterno, ma non è così dal punto di vista del bambino. Né viene dall'interno; non è una allucinazione.
7. Il suo destino è che gli venga gradualmente consentito di essere disinvestito in modo tale che, nel corso degli anni, non tanto venga dimenticato quanto, piuttosto, relegato in un limbo. Con ciò intendo che, di norma, l'oggetto transizionale non 'va dentro' né vanno necessariamente incontro a rimozione le sensazioni relative. Non viene dimenticato e non c'è lutto per esso. Perde significato e ciò perché i fenomeni transizionali divengono diffusi, occupano l'intero territorio intermedio tra la 'realtà psichica interna' e 'il mondo esterno come viene percepito, in modo comune, tra due persone', vale a dire l'intera area culturale.

A questo punto il tema si estende a quello del gioco, della creatività e dell'apprezzamento artistici, del sentimento religioso, del sognare, e anche del feticismo, del mentire e del rubare, dell'origine e perdita del sentimento d'affetto, della dipendenza dalla droga, del talismano dei rituali ossessivi, ecc.

Rapporto fra oggetto transizionale e simbolismo

È vero che il pezzo di coperta (o quel che è) è simbolico di qualche oggetto parziale, come il seno. Tuttavia, la sua importanza non è per il valore simbolico ma per il suo essere reale. Il suo non essere il seno (o la madre), sebbene sia vero, è altrettanto importante del fatto che esso stia per il seno (o la madre).

Quando entra in gioco il simbolismo, il bambino distingue già chiaramente tra fantasia e realtà, tra oggetti interni e oggetti esterni, tra creatività primaria e percezione. Ma il termine oggetto transizionale, secondo me, dà l'accesso al processo di diventare capace di accettare la differenza e la somiglianza. Penso che sia utile avere un termine che indichi la radice del simbolismo nel tempo, un termine che descriva il percorso del bambino dal puramente soggettivo all'oggettività; e mi sembra che l'oggetto transizionale (pezzo di coperta, ecc.) sia ciò che vediamo di questo percorso graduale verso l'esperienza.

Sarebbe possibile comprendere l'oggetto transizionale pur non comprendendo completamente la natura del simbolismo. Sembra che il simbolismo possa essere adeguatamente studiato soltanto nel processo di crescita dell'individuo e che, nel migliore dei casi, abbia un significato variabile. Per esempio, se consideriamo l'ostia del Santissimo Sacramento che è il simbolo del corpo di Cristo, penso di aver ragione di dire che per i cattolici l'ostia *è* il corpo di Cristo e per i Protestanti è un *sostituto*, un promemoria, e essenzialmente non è, di fatto, il corpo stesso. Ma, in entrambi i casi, è un simbolo.

Descrizione clinica dell'oggetto transizionale

Per chiunque sia in contatto con genitori e bambini, esiste un'infinita quantità e varietà di materiale clinico illustrativo. Le seguenti illustrazioni vengono proposte semplicemente per ricordare ai lettori il materiale analogo nella loro esperienza.

Due fratelli: differenza nell'uso precoce degli oggetti posseduti

Distorsione nell'uso dell'oggetto transizionale. X, che ora è un uomo sano, ha avuto un percorso faticoso verso la maturità. La madre 'imparava a fare la madre' occupandosi di X quando questi era piccolo e aveva capito come evitare alcuni errori con gli altri figli grazie a ciò che aveva appreso con lui. C'erano anche motivi esterni per i quali era angosciata nel periodo in cui si era occupata di X appena nato praticamente da sola. Aveva preso molto sul serio il suo compito di madre e allattò X per sette mesi. Adesso ritiene che l'allattamento per X sia stato eccessivamente prolungato ed era stato molto difficile svezzarlo. Non aveva mai succhiato il pollice o altre dita e, quando lo svezzò, X 'non aveva nulla su cui ripiegare'. Non aveva mai preso il biberon o avuto un pupazzo o sperimentato un altro tipo di alimentazione. Aveva un *attaccamento* molto forte e precoce *esclusivamente per lei*, come persona, ed era proprio della sua persona che il bambino aveva bisogno.

Dai dodici mesi adottò un coniglietto che coccolava, e il suo rapporto affettuoso verso il pupazzo si trasferì, successivamente, ai conigli veri. Questo particolare

coniglio durò fino ai cinque o sei anni. Poteva essere descritto come un *consolatore*, ma non ebbe mai veramente la caratteristica di oggetto transizionale. Non fu mai, come sarebbe stato nel caso di un vero oggetto transizionale, più importante della madre, una parte quasi inseparabile del bambino. Nel caso specifico di questo bambino, le angosce insorte con lo svezzamento sette mesi dopo produssero un'asma che soltanto gradualmente X riuscì a gestire. Fu importante per lui trovare un impiego lontano dalla sua città. L'attaccamento alla madre è ancora molto forte sebbene si possa definire, in senso lato, normale o sano. Quest'uomo non si è sposato.

* * *

Uso tipico dell'oggetto transizionale. Il fratello più giovane di X, Y, è cresciuto in modo assolutamente lineare. Attualmente ha tre figli sani. Era stato allattato al seno per quattro mesi e, poi, svezzato senza problemi. Y si succhiò il pollice nelle prime settimane di vita e anche questo 'ha reso lo svezzamento più facile per lui rispetto al fratello più grande'. Ben presto, dopo lo svezzamento, dai cinque ai sei mesi, adottò il bordo della coperta nel punto in cui finivano le cuciture. Gli piaceva se un po' di lana spuntava dall'angolo e con questa si solleticava il naso. Molto presto questo diventò il suo 'Baa'; egli stesso inventò questo nome non appena fu in grado di utilizzare suoni più complessi. Quando ebbe circa un anno, fu capace di sostituire al bordo della coperta un morbido golfino verde con una cravatta rossa. Questo non era un 'consolatore' come nel caso del fratello maggiore depresso, ma un 'calmante'. Era un sedativo che funzionava sempre. Questo è un esempio tipico di ciò che chiamo

oggetto transizionale. Quando era piccolo, si poteva star sicuri che se qualcuno gli dava il suo 'Baa', Y se lo sarebbe immediatamente succhiato e avrebbe superato ogni angoscia e, in effetti, si addormentava in pochi minuti se l'ora della nanna era più o meno vicina. Nello stesso tempo continuò a succhiare il pollice, e questo durò fino a che ebbe tre o quattro anni, fatto che Y ricorda ancora insieme al piccolo callo sul pollice che ne era derivato. Adesso è interessato (come padre) al fatto che i suoi figli succhino il pollice e al loro uso di vari 'Baa'.

La storia dei sette bambini normali di questa famiglia mostra i seguenti aspetti, inseriti qui sotto in una tabella comparativa:

		Pollice	Oggetto		Tipo di bambino
X	Maschio	o	Madre	Coniglio (consolatore)	Fissato sulla madre
Y	Maschio	+	"Baa"	Golfino (calmante)	Libero
Gemelli	Femmina	o	Pupazzo	Somarello (amico)	Maturaz. tardiva
	Maschio	o	"Ee"	Ee (ogg. protettivo)	Psicopatico latente
Bambini di Y	Femmina	o	"Baa"	Copertina (rassicurazione)	Buono sviluppo
	Femmina	+	Pollice	Pollice (soddisfazione)	Buono sviluppo
	Maschio	+	"Mimis"	Oggetti (vari)*	Buono sviluppo

* Nota aggiuntiva: Questo non era chiaro, ma l'ho lasciato com'era. DWW, 1971.

L'importanza dell'anamnesi

Nella consultazione con un genitore è spesso utile avere informazioni sulle prime modalità e i primi oggetti posseduti di tutti i bambini della famiglia. Ciò mette in moto nella madre un confronto tra un figlio e l'altro e le fa ricordare e paragonare le loro caratteristiche nella primissima infanzia.

Il contributo del bambino

Spesso si possono avere informazioni sull'oggetto transizionale dal bambino stesso. Per esempio:

> Angus (undici anni e nove mesi) mi disse che il fratello 'aveva un sacco di orsacchiotti di pezza e di cose', e che 'prima di questo aveva degli orsetti' e dopo continuò parlandomi della propria storia. Disse che lui non aveva mai avuto orsacchiotti di stoffa. C'era il cordone di un campanello che pendeva, lui ne colpiva l'estremità e così si addormentava. Probabilmente alla fine si staccò e così la storia finì. C'era, tuttavia, anche qualche altra cosa. Era molto reticente su questo. Era un coniglio viola con gli occhi rossi. 'Non è che mi piacesse tanto.. Di solito lo buttavo da tutte le parti. Ora ce l'ha Jeremy, gliel'ho dato io. L'ho dato a Jeremy perché era cattivo. *Sarebbe caduto* dal cassettone. *Ancora mi viene a trovare. Mi fa piacere che mi venga a trovare*'. Si sorprese quando si trovò a disegnare il coniglio viola.

Si potrà notare che questo ragazzo di undici anni con un senso di realtà normale per la sua età, parlava come se mancasse di senso di realtà nel momento in cui descriveva

qualità ed attività dell'oggetto transizionale. Quando la vidi più tardi la madre rimase sorpresa del fatto che Angus si ricordasse del coniglio viola che riconobbe subito dal disegno colorato.

Grande disponibilità di esempi

Non aggiungo di proposito altri esempi clinici, soprattutto perché vorrei evitare di dare l'impressione che ciò di cui parlo si riscontri raramente. Invece, praticamente in ogni anamnesi si può trovare qualcosa di interessante rispetto ai fenomeni transizionali, o alla loro mancanza.

Studio teorico

Si possono fare alcuni commenti sulla base della teoria psicoanalitica generalmente accettata:

1. L'oggetto transizionale sta per il seno, o per l'oggetto della prima relazione.
2. L'oggetto transizionale precede un esame di realtà consolidato.
3. In rapporto con l'oggetto transizionale il bambino passa dal controllo onnipotente (magico) al controllo mediante la manipolazione (che implica erotismo muscolare e piacere nella coordinazione).
4. L'oggetto transizionale può diventare a volte un oggetto feticcio e come tale persistere come caratteristica della vita sessuale adulta. (Vedi come Wulff (1946) ha sviluppato questo tema).
5. L'oggetto transizionale può, per via di una organizzazione anale erotizzata, rappresentare le feci (ma non

è per questa ragione che talvolta diventa puzzolente e non deve essere lavato).

Il rapporto con l'oggetto interno (Klein)

È interessante confrontare il concetto di oggetto transizionale con quello di oggetto interno di Melanie Klein (1934). L'oggetto transizionale *non è un oggetto interno* (che è un concetto mentale), è un possesso. Ma non è (per il bambino) nemmeno un oggetto esterno.

Bisogna fare un'affermazione complessa. Il bambino può usare un oggetto transizionale quando l'oggetto interno è vivo e reale e sufficientemente buono (non troppo persecutorio). Ma questo oggetto interno dipende, per le sue qualità, dall'esistenza, dalla vitalità e dal comportamento dell'oggetto esterno. Se quest'ultimo viene meno in qualche funzione essenziale, ciò porta alla morte o alla qualità persecutoria dell'oggetto interno[2]. Se persiste l'inadeguatezza dell'oggetto esterno, l'oggetto interno smette di avere significato per il bambino e allora, e soltanto allora, l'oggetto transizionale diventa anch'esso insignificante. L'oggetto transizionale può, quindi, stare per il seno 'esterno' ma *indirettamente*, attraverso il rappresentare il seno 'interno'.

L'oggetto transizionale non è mai sotto controllo magico come l'oggetto interno né è del tutto fuori controllo come la madre reale.

[2] Il testo qui è modificato, pur essendo basato sul lavoro originale.

Illusione-disillusione

Al fine di preparare il terreno per il mio contributo in positivo su questo tema, devo mettere in parole alcune cose che penso che vengano date per scontate troppo facilmente in molti scritti psicoanalitici sullo sviluppo emozionale infantile, anche se si possono comprendere in pratica.

Non vi è alcuna possibilità per il bambino di procedere dal principio del piacere al principio di realtà, o verso e oltre l'identificazione primaria (vedi Freud, 1923), se non c'è una madre sufficientemente buona. La 'madre' sufficientemente buona (non necessariamente la madre vera del bambino) è quella che attivamente si adatta ai bisogni del bambino, un adattamento attivo che a poco a poco diminuisce a seconda della capacità del bambino che cresce di rendersi conto del venir meno dell'adattamento e di tollerare gli effetti della frustrazione. Naturalmente, è più facile che sia la madre vera del bambino ad essere abbastanza buona piuttosto che un'altra persona, dal momento che questo adattamento attivo richiede un'attenzione verso il bambino spontanea e senza risentimento; di fatto, riuscire ad occuparsi bene di un bambino dipende dal modo in cui ci si dedica a lui, non dall'abilità e dalla spiegazione intellettuale.

La madre sufficientemente buona, come ho detto, comincia con un adattamento quasi totale ai bisogni del bambino e, a mano a mano che il tempo passa, vi si adatta sempre meno, a seconda della crescente capacità del bambino di far fronte alle sue mancanze.

I mezzi che il bambino ha per affrontare questo venir meno da parte della madre comprendono:

1. L'esperienza del bambino, più volte ripetuta, che la frustrazione è limitata nel tempo. All'inizio, naturalmente, questo limite di tempo deve essere breve.
2. Il senso crescente di processo.
3. L'inizio dell'attività mentale.
4. L'impiego di soddisfazioni autoerotiche.
5. Ricordare, rivivere, fantasticare, sognare; integrare passato, presente e futuro.

Se tutto va bene, il bambino può in effetti ottenere un vantaggio dall'esperienza di frustrazione, poiché l'adattamento incompleto al bisogno rende gli oggetti reali, vale a dire odiati altrettanto quanto amati. La conseguenza è che, *se tutto va bene*, il bambino può essere disturbato da un adattamento al bisogno perfetto che continui troppo a lungo e al quale non venga consentito il naturale decrescere, dal momento che un adattamento perfetto è come una magia e l'oggetto che si comporta in modo perfetto è come un'allucinazione. Però, *all'inizio*, l'adattamento deve essere quasi perfetto dal momento che, se non è così, non è possibile che il bambino cominci a sviluppare la capacità di sperimentare il rapporto con la realtà esterna, o anche di formarsi un'idea della realtà esterna.

L'illusione e l'importanza dell'illusione

La madre, all'inizio, con un adattamento quasi al cento per cento, offre al bambino la possibilità dell'*illusione* che il seno sia parte di lui. Così il seno è, per così dire, sotto il controllo magico del bambino. Lo stesso si può dire rispetto alle cure materne in generale, nei periodi di quiete che si alternano a quelli di eccitazione. L'onnipotenza è, grosso modo, un fatto di esperienza. Il compito finale della madre è di disilludere gradatamente il bambino, ma non ha alcuna possibilità di riuscire a meno che non sia stata capace all'inizio di offrire sufficienti occasioni di illusione.

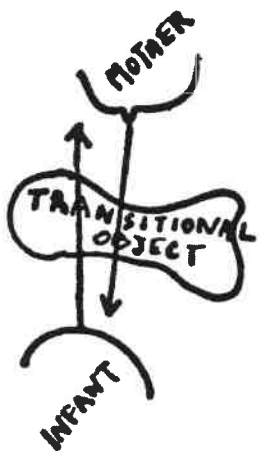
In altri termini, il seno viene creato dal bambino più e più volte a partire dalla sua capacità di amare o (si potrebbe dire) dal suo bisogno. Nel bambino si sviluppa un fenomeno soggettivo, che si chiama seno materno[3]. La madre mette il seno reale proprio là dove il bambino è pronto a crearlo, e al momento giusto.

Dalla nascita, pertanto, l'essere umano è preso dal problema del rapporto tra ciò che è percepito oggettivamente e ciò che è soggettivamente concepito e, nella soluzione di questo problema, l'essere umano non può essere sano se la madre non gli ha dato un inizio sufficientemente buono. *L'area intermedia alla quale mi riferisco è l'area che è consentita al bambino tra la creatività primaria e la percezione oggettiva basata sull'esame di realtà.* I fenomeni transizionali rappresentano i primi stadi dell'uso dell'illusione, senza la quale non può avere significato per l'essere umano l'idea del rapporto con un oggetto che è percepito dagli altri come esterno a quell'essere umano.

L'idea illustrata nella *Figura* 1 è questa: nel primo sviluppo di ogni individuo umano, in un punto teorico, un bambino in un determinato contesto fornito dalla madre è capace di concepire l'idea di qualcosa che potrebbe soddisfare il bisogno crescente che nasce a partire dalla

[3] Comprendo con questo termine l'intera tecnica delle cure materne. Quando si dice che il primo oggetto è il seno, la parola "seno" viene usata, credo, sia per la tecnica delle cure materne sia per il seno fisicamente inteso. Non è impossibile che una madre sia sufficientemente buona (nel modo in cui l'intendo io) anche se allatta con il biberon invece che al seno.

tensione istintuale. Non si può dire che il bambino sappia, all'inizio, che cosa debba essere creato. In questo preciso momento la madre si presenta. Con naturalezza offre il seno e il proprio impulso potenziale a nutrire. Quando è sufficientemente buono, l'adattamento della madre ai bisogni del bambino dà al bambino l'*illusione* che vi sia una realtà esterna che corrisponde alla sua capacità di creare. In altri termini, c'è una sovrapposizione tra ciò che la madre fornisce e ciò che il bambino può concepire su questo. Per l'osservatore il bambino percepisce ciò che la madre presenta veramente, ma questa non è tutta la verità. Il bambino percepisce il seno solo nella misura in cui il seno può essere creato proprio lì e in quel momento. Non v'è alcuno scambio tra madre e bambino. Psicologicamente il bambino prende il latte da un seno che è parte del bambino e la madre dà il latte ad un bambino che è parte di sè. In psicologia, l'idea di uno scambio è basata sull'illusione dello psicologo.



Nella *Figura* 2 l'area dell'illusione viene rappresentata con una forma per descrivere quella che penso sia la funzione principale dell'oggetto transizionale e dei fenomeni transizionali. L'oggetto transizionale e i fenomeni transizionali avviano ciò che sarà sempre importante per ogni essere umano, vale a dire un'area neutra di esperienza che non verrà messa in discussione. *Dell'oggetto transizionale si può dire che si tratta di un patto tra noi e il bambino sul fatto che non faremo mai la domanda: 'Lo hai concepito tu o ti si è presentato da fuori?'. La cosa importante è che non ci si aspetta alcuna presa di posizione su questo punto. Semplicemtente la domanda non deve essere formulata.*

Questo problema, che all'inizio indubbiamente riguarda il bambino in un modo impercettibile, gradualmente diventa un problema ovvio per il fatto che il compito principale della madre (subito dopo quello di dare la possibilità dell'illusione) è quello di disilludere. Questo succede anche prima dello svezzamento e continua, poi, come compito di genitori e educatori. In altri termini, questa questione dell'illusione appartiene intrinsecamente agli esseri umani, e nessun individuo alla fine lo risolve da solo, anche se una comprensione *teorica* di esso può fornire una soluzione *teorica*. Se le cose vanno bene, in questo graduale processo di disillusione, si prepara la scena per le frustrazioni che si racchiudono nel termine svezzamento; ma si dovrebbe ricordare che quando parliamo dei fenomeni (che la Klein (1940) aveva specificamente messo in luce nel concetto di posizione depressiva) che si raggruppano intorno allo svezzamento, intendiamo il processo sottostante, quello attraverso il quale viene fornita l'occasione per l'illusione e la graduale disillusione. Se l'illusione-disillusione è andata fuori strada, il bambino non può arrivare a una

cosa tanto normale come lo svezzamento, né alla reazione allo svezzamento e, allora, è del tutto assurdo riferirsi allo svezzamento. Il semplice terminare l'allattamento al seno non è svezzamento.

Possiamo vedere l'enorme significato dello svezzamento nel bambino normale. Quando osserviamo la reazione complessa che si avvia in un bambino con lo svezzamento, sappiamo che ciò può avvenire in quel bambino perché il processo di illusione-disillusione si realizza così bene che possiamo ignorarlo mentre parliamo dello svezzamento reale.

Lo sviluppo della teoria su illusione-disillusione

Si assume, a questo punto, che il compito di accettazione-della-realtà non è mai veramente completato, che nessun essere umano è libero dalla tensione di mettere in rapporto la realtà interna e la realtà esterna e che il sollievo da questa tensione è dato dall'area intermedia di esperienza (cfr. Riviere, 1936) che non viene messa in discussione (arte, religione, ecc.). Questa area intermedia è in diretta continuità con l'area del gioco del bambino piccolo, che 'si perde' nel gioco.

Nell'infanzia quest'area intermedia è necessaria per dare inizio al rapporto tra il bambino ed il mondo ed è resa possibile da cure materne abbastanza buone in una fase cruciale precoce. Essenziale per tutto ciò è la continuità (nel tempo) dell'ambiente emozionale esterno e di particolari elementi nell'ambiente fisico quali l'oggetto o gli oggetti transizionali.

I fenomeni transizionali sono possibili per il bambino a causa del riconoscimento per intuito, da parte dei genitori,

della tensione insita nella percezione oggettiva e là dove c'è un oggetto transizionale non si pone al bambino la questione di soggettività o oggettività.

Se un adulto pretendesse l'accettazione dell'oggettività dei suoi fenomeni soggettivi, individueremmo o diagnosticheremmo la follia. Se, però, l'adulto trova il modo di star bene nell'area intermedia personale senza richiedere nulla, possiamo riconoscere le nostre personali aree intermedie corrispondenti e ci fa piacere di trovare un certo grado di sovrapposizione, vale a dire l'esperienza comune tra i membri di un gruppo nell'arte, nella religione o nella filosofia.

Riassunto

Viene richiamata l'attenzione sul ricco terreno osservativo fornito dalle primissime esperienze del bambino sano come vengono espresse principalmente in rapporto al primo possesso.

Questo primo possesso viene messo in rapporto retrospettivamente con i fenomeni autoerotici e con il succhiare il dito e il pugno e, in prospettiva, con il primo peluche o con la bambola o con i giocattoli duri. Viene messo in relazione sia con l'oggetto esterno (seno della madre) che con gli oggetti interni (seno magicamente introiettato), ma è diverso da entrambi.

Gli oggetti transizionali e i fenomeni transizionali appartengono al regno dell'illusione che è alla base dell'inizio dell'esperienza. Questo primo stadio di sviluppo è reso possibile dalla speciale capacità della madre di adattarsi ai bisogni del bambino, dandogli così l'illusione che ciò che egli crea esiste davvero.

Quest'area intermedia di esperienza, indiscussa rispetto al suo appartenere alla realtà interna o esterna (condivisa), costituisce la maggior parte dell'esperienza del bambino e per tutta la vita viene mantenuta nell'intensa esperienza di arti, religione, vivere immaginativo e nel lavoro scientifico creativo.

Un oggetto transizionale di un bambino diventa di norma gradualmente disinvestito specialmente man mano che si sviluppano gli interessi culturali.

Ciò che emerge da queste considerazioni è l'altra idea che un paradosso accettato può avere un valore positivo. La risoluzione di un paradosso porta a un'organizzazione difensiva che nell'adulto si può riscontrare come vera e falsa organizzazione del sé (Winnicott, 1960 a).

II. Un'applicazione della teoria

Non è l'oggetto, naturalmente, che è transizionale. L'oggetto rappresenta la transizione del bambino dallo stato di essere fuso con la madre allo stato di essere in rapporto con la madre in quanto esterna e separata. Ci si riferisce spesso a questo momento come a quello in cui il bambino crescendo supera il rapporto oggettuale narcisistico, ma non ho voluto usare questo tipo di linguaggio perché non sono sicuro che esprima ciò che intendo; in più, quei termini lasciano fuori l'idea della dipendenza, che è così essenziale nei primissimi stadi, prima che il bambino sia diventato sicuro che esista qualcosa che non sia parte di sé.

Manifestazioni psicopatologiche nell'area dei fenomeni transizionali

Ho sottolineato molto la normalità dei fenomeni transizionali. Tuttavia, deve essere individuato l'aspetto psicopatologico nel corso dell'esame clinico dei casi. Come esempio della gestione, da parte del bambino, della separazione e della perdita, voglio prendere in considerazione il modo in cui la separazione può influenzare i fenomeni transizionali.

Come si sa, quando la madre o qualcun altro da cui il bambino dipende è assente, non vi è alcun cambiamento immediato per il fatto che il bambino ha il ricordo o l'immagine mentale della madre o la cosiddetta rappresentazione interna di lei che resta viva per un certo tempo. Se la madre è via per un periodo di tempo che va oltre un dato limite, misurato in minuti, ore, o giorni, il ricordo o rappresentazione interna svanisce. Man mano che questo avviene, i fenomeni transizionali diventano gradatamente privi di significato e il bambino non è in grado di farne esperienza. Potremmo osservare l'oggetto mentre viene disinvestito. Immediatamente prima della perdita, talvolta si può osservare un uso esagerato dell'oggetto transizionale come *diniego* del rischio che perda di significato. Per illustrare questo aspetto del diniego, darò un breve esempio clinico relativo all'uso che un bambino fa di una cordicella.

La cordicella[4]

Nel marzo del 1955, un bambino di sette anni fu portato al reparto di psicologia del Paddington Green Children's Hospital dalla madre e dal padre. Vennero anche gli altri due membri della famiglia: una bambina di dieci anni che frequentava una scuola per bambini subnormali e una bambina praticamente normale di quattro anni. Il caso fu inviato dal medico di famiglia per via di una serie di sintomi che segnalavano un disturbo nel carattere del bambino. Dal test intellettivo risultava un QI di 108. (Allo scopo di questa descrizione tutti i dettagli che non sono immediatamente rilevanti per il tema principale di questo capitolo saranno omessi).

Dapprima incontrai i genitori per un lungo colloquio nel quale mi diedero un quadro esauriente dello sviluppo del bambino e delle distorsioni di esso. Trascurarono, però, un dettaglio importante che emerse nel colloquio con il bambino.

Non fu difficile accorgersi che la madre era una persona depressa e lei stessa riferì di essere stata ospedalizzata per depressione. Dal resoconto dei genitori notai che la madre si era occupata del bambino fino alla nascita della sorella, quando lui aveva tre anni e tre mesi. Questa fu la prima separazione importante e la successiva avvenne a tre anni e undici mesi, quando la madre subì un intervento chirurgico. Quando il bambino aveva quattro anni e nove mesi, la madre fu ricoverata per due mesi in ospedale psichiatrico e, in quel periodo, il bambino fu accudito dalla sorella della madre. All'epoca, chiunque si occupava di questo ragazzo conveniva sul fatto che

[4] Pubblicato in *Child Psychology and Psychiatry*, vol.1 (1960c); e in Winnicott, *Sviluppo affettivo e ambiente* (1965a).

era difficile, pur mostrando grandi qualità. Era capace di trasformarsi all'improvviso e di spaventare tutti dicendo, per esempio, che avrebbe fatto a pezzettini la sorella della madre. Sviluppò molti sintomi curiosi come la compulsione a leccare cose e persone; faceva dei rumori compulsivi con la gola; spesso rifiutava di andare in bagno e poi si sporcava. Era ovviamente angosciato dall'handicap della sorella maggiore, ma il suo disturbo di sviluppo sembrava essere iniziato prima che questo fattore potesse essere significativo.

Dopo questo colloquio con i genitori, vidi il ragazzo per un colloquio individuale. Erano presenti due assistenti sociali e due stagisti. Il ragazzo non dava subito l'impressione di anormalità e entrò rapidamente nel gioco dello scarabocchio con me. (In questo gioco dello scarabocchio, faccio di getto uno scarabocchio sul foglio e invito il bambino a farlo diventare qualche cosa, e poi lui fa uno scarabocchio per me e io, a mia volta, lo faccio diventare qualcosa).

In questo caso particolare, il gioco dello scarabocchio portò a un curioso risultato. La pigrizia del bambino divenne subito evidente e, inoltre, qualunque cosa facessi, veniva trasformata da lui in qualcosa associato con la corda. Tra i suoi dieci disegni, apparvero:

lazo
frusta
frustino
corda di yo-yo
spago annodato
un altro frustino
un'altra frusta

Dopo questo colloquio con il bambino, ne ebbi un secondo con i genitori e chiesi notizie sull'interesse del ragazzo per le corde. Dissero che erano contenti che io avessi sollevato questo argomento che non avevano menzionato perché non erano sicuri della sua importanza. Dissero che il ragazzo era diventato ossessionato da qualsiasi cosa avesse a che fare con le corde e che, in effetti, ogni volta che andavano in una stanza era probabile che avrebbero trovato che aveva legato sedie e tavoli; potevano trovare, ad esempio, un cuscino legato con una cordicella al camino. Dicevano che l'interesse del ragazzo per la corda stava gradualmente prendendo un nuovo aspetto che li aveva veramente preoccupati invece di incuriosirli come al solito. Di recente aveva legato una corda al collo della sorella (quella la cui nascita aveva prodotto la prima separazione di questo bambino dalla madre).

In un colloquio di questo tipo, sapevo di avere poche possibilità di intervento: la famiglia viveva in campagna e non sarebbe stato possibile vedere questi genitori o il ragazzo più di una volta ogni sei mesi. Pertanto mi regolai così. Spiegai alla madre che questo bambino affrontava la paura della separazione e cercava di negarla facendo uso della cordicella, così come uno negherebbe la separazione da un amico usando il telefono. La madre era scettica, ma le dissi che se avesse trovato modo di dar senso a ciò che le spiegavo, mi sarebbe piaciuto che ritornasse sull'argomento con il bambino al momento giusto per fargli sapere quello che avevo detto e, poi, portare avanti l'argomento della separazione a seconda della sua risposta.

Non seppi più nulla di loro fino a che non tornarono da me, dopo circa sei mesi. La madre non mi riferì ciò

che aveva fatto ma io glielo chiesi ed lei mi raccontò ciò che era successo subito dopo la visita da me. Aveva pensato che avevo detto delle sciocchezze, ma una sera aveva aperto il discorso con il bambino e aveva scoperto che era ansioso di parlare del suo rapporto con lei e della sua paura della mancanza di contatto con lei. Ripensò, allora, con lui a tutte le separazioni che le vennero in mente e subito, sulla base delle sue risposte, si convinse che avevo ragione. Inoltre, dal momento in cui ebbe luogo questa conversazione, il gioco della corda cessò. Non ci fu più il legare gli oggetti come prima. Aveva parlato molte altre volte con il bambino sul suo sentirsi separato da lei e fece un commento davvero significativo sul fatto che sentiva che la separazione più importante era stata la perdita di lei quando era stata gravemente depressa; non era stato soltanto il suo andare via, disse, ma la sua mancanza di contatto con lui per il fatto che era completamente presa da altri problemi.

In un colloquio successivo, la madre mi disse che un anno dopo avere parlato per la prima volta con il bambino, c'era stata una ripresa del gioco con la cordicella e del legare gli oggetti in casa. In effetti la madre doveva andare in ospedale per un intervento e gli disse: 'Dal fatto che giochi con la corda, capisco che sei preoccupato perché vado via, ma questa volta starò lontana solo pochi giorni, e l'intervento è una cosa da niente'. Dopo questa comunicazione, la nuova fase del gioco della corda cessò.

Sono rimasto in contatto con questa famiglia e li ho aiutati con vari consigli per i problemi scolastici del ragazzo e altre questioni. Recentemente, quattro anni dopo il primo colloquio, il padre ha raccontato di una nuova fase di interesse per le corde, connessa a una nuova depressione della madre. Questa fase è durata due mesi; è

terminata quando l'intera famiglia è andata in vacanza e quando, contemporaneamente, vi è stato un miglioramento nella situazione familiare (il padre ha trovato lavoro dopo un periodo di disoccupazione). In concomitanza con questo, c'è stato un miglioramento delle condizioni della madre. Il padre ha fornito un altro particolare rilevante per l'argomento in questione. Durante questa fase recente, il bambino aveva fatto qualcosa con la corda che il padre aveva considerato molto significativo, perché mostrava quanto intimamente tutto questo fosse connesso con l'angoscia patologica della madre. Un giorno era tornato a casa e aveva trovato il bambino che pendeva a testa in giù attaccato a una fune. Era del tutto abbandonato e faceva finta, in modo molto verosimile, di essere morto. Il padre aveva capito che non doveva dar peso alla cosa e si aggirò in giardino facendo varie cose per mezz'ora, dopo di che il ragazzo si annoiò e mise fine al gioco. Questa fu una grande prova della mancanza di angoscia da parte del padre. Il giorno dopo, però, il ragazzo aveva fatto la stessa cosa da un albero che si vedeva benissimo dalla finestra della cucina. La madre si era precipitata fuori terrorizzata e sicura che si fosse impiccato.

Un altro dettaglio può essere utile per comprendere il caso. Sebbene questo bambino, che ora ha undici anni, stia crescendo come un 'duro', è molto timido e facilmente arrossisce sul collo. Ha un gran numero di orsacchiotti che per lui sono figli. Nessuno osa dire che sono giocattoli. È fedele verso di loro, riversa su di essi un grande affetto e fa per loro dei pantaloncini che richiedono un accurato lavoro di cucito. Suo padre dice che egli sembra ricavare un senso di sicurezza dalla sua 'famiglia', della quale si prende cura in modo materno. Se arrivano visite,

mette rapidamente gli orsacchiotti sul letto della sorella perché nessuno, al di fuori dei familiari, deve sapere che ha questa sua famiglia. Oltre a questo c'è una certa difficoltà a defecare o la tendenza a trattenere le feci. Non è difficile capire, quindi, che ha un'identificazione con la madre basata sulla propria insicurezza nel rapporto con lei, e che ciò potrebbe svilupparsi in una omosessualità. Nello stesso modo, la fissazione per le corde potrebbe svilupparsi in una perversione.

Commento

Sembra appropriato il commento qui di seguito:

1. La corda può essere considerata come un'estensione di tutte le altre tecniche di comunicazione. Essa unisce, così come è utile per impacchettare gli oggetti e per contenere materiale non integrato. Sotto questo aspetto, la corda ha un significato simbolico per tutti; una esagerazione nell'uso dello spago può facilmente essere attribuita ad un iniziale senso di insicurezza o all'idea di una mancanza di comunicazione. In questo particolare caso è possibile rilevare l'anormalità che traspare nell'uso che fa il bambino della cordicella e è importante trovare il modo di definire il passaggio che potrebbe portare il suo uso a diventare perversione. Sembrerebbe possibile arrivare a una tale definizione se si prende in considerazione il fatto che la funzione dello spago è di trasformare la comunicazione in un *diniego della separazione*. Come diniego della separazione, la corda diventa una cosa in sé, qualcosa che ha proprietà pericolose e deve essere padroneggiata. In questo caso, sembra che la madre sia stata in grado di affrontare il problema della corda prima che

fosse troppo tardi, quando l'uso che il bambino ne faceva conteneva ancora la speranza. Quando la speranza è assente e la corda rappresenta il diniego della separazione, si determina uno stato di cose assai più complesso – uno stato di cose che diventa difficile da curare, per via del vantaggio secondario che deriva dall'abilità che si sviluppa ogniqualvolta un oggetto deve essere manipolato per poter essere padroneggiato. Questo caso, pertanto, è di particolare interesse in quanto rende possibile l'osservazione dello sviluppo della perversione.

2. È anche possibile vedere, attraverso questo materiale clinico, l'uso che si può fare dei genitori. Quando i genitori possono essere utilizzati, possono funzionare con grande risparmio, specialmente se si tiene in mente il fatto che non vi saranno mai abbastanza psicoterapeuti per trattare tutti coloro che hanno bisogno di un trattamento. Qui c'era una buona famiglia che aveva passato un periodo difficile per via della disoccupazione del padre; che era stata in grado di assumersi la piena responsabilità di una ragazza ritardata, nonostante i grandi inconvenienti che ciò comportava sia nella società che nell'ambito familiare; e che aveva superato le fasi negative della malattia depressiva della madre, compresa una fase di ospedalizzazione. Ci deve essere stata una grande forza in una famiglia così e fu sulla base di questo assunto che fu presa la decisione di invitare questi genitori ad intraprendere la terapia del proprio bambino. Nel fare ciò essi hanno imparato molto di se stessi, ma avevano bisogno di sapere ciò che stavano facendo. Avevano anche bisogno che la loro riuscita fosse apprezzata e che l'intero processo venisse verbalizzato. Il fatto di avere seguito il figlio attraverso la malattia ha dato ai genitori

fiducia riguardo alla loro capacità di affrontare le altre difficoltà che potevano eventualmente insorgere.

Nota aggiunta nel 1969

Nei dieci anni trascorsi da quando questo resoconto è stato scritto, ho dovuto convincermi che questo ragazzo non avrebbe potuto essere curato per la sua malattia. Il legame con la malattia depressiva della madre rimase, così che non gli si poteva impedire di tornare a casa. Lontano da casa, avrebbe potuto avere un trattamento individuale, ma a casa questo era impraticabile. A casa il ragazzo manteneva lo schema che era già presente al momento del primo colloquio.

In adolescenza questo ragazzo sviluppò nuove dipendenze, specialmente dalle droghe, e non fu in grado di lasciare la famiglia per andare a studiare. Tutti i tentativi di sistemarlo lontano dalla madre fallirono, perché regolarmente scappava e tornava a casa.

Divenne un adolescente insoddisfatto, buttato qua e là, che apparentemente sprecava il suo tempo e il suo potenziale intellettivo (come rilevato più sopra aveva un QI di 108).

La questione è: se un ricercatore facesse uno studio di questo caso di tossicomania, darebbe la dovuta attenzione alla psicopatologia manifestata nell'area dei fenomeni transizionali?